

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍA	
	Historia # 00013	Fecha De Impresión: 15-04-2026 09:18:14

Datos Personales							
Nombre:	LUIS GABRIEL ZUBIRIA QUIÑONEZ	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2012-01-13	Edad	14 Años, 3 Meses, Y 2 Días
Identificación:	TI - 1091364684	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Jairo.Zujiria@gmail.Com - 1091364684			Dirección:	Calle 8 # 26A 25 Aguachica		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		ALBA MARTIZA QUINONEZ - Parentesco (madre) - Teléfono (310 8879764)					

Apertura psicología del 2025-11-18 20:50:59: 14 años, 3 meses, y 2 días

DATOS GENERALES

Remisión
Particular
Código de consulta
890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA
Motivo de Consulta
Refiere la madre “Jairo y yo nos estamos separando y Luis no quiere acercarse al papá y es muy fuerte” “deseo que Luis mejore la relación con Jairo”.
Enfermedad Actual
El paciente presenta un cuadro que se manifiesta desde la primera infancia, caracterizado por dificultades para vincularse con otros niños; suele sentirse apartado y, según refiere la madre, expresa que “prefiere jugar con niñas y no con niños”. La relación con su padre se ha desmejorado. La madre lo describe como un menor con altas capacidades cognitivas, aunque con marcada distractibilidad: se queda retrasado en los dictados, no completa las tareas por escrito y no le va bien en algunas materias. Desde aproximadamente el año 2018 ha mostrado episodios de conducta agresiva; aunque estos han disminuido tanto en intensidad como en frecuencia, anteriormente reaccionaba con llanto ante múltiples situaciones. Le cuesta integrarse socialmente y solo logra relacionarse cuando percibe confianza y un ambiente cálido. Es bilingüe, prefiere vestir ropa negra y presenta selectividad alimentaria. Es sensible a ciertos sonidos y con frecuencia habla para si mismo en voz baja sin un lenguaje entendible.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico	Tóxicos
No Refiere	No Refiere
Traumáticos	Medicación
Ninguno	No Refiere
Paraclínicos	Hospitalizaciones
No Refiere	No Refiere
Patología	
No Refiere	

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo	Enfermedades De La Madre
45 Años	No
Único Embarazo	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica
No	Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo	Estado De La Madre Durante El Embarazo
No	Normal

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea No Refiere
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 54
Talla Al Nacer 4000 Kg	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere
--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 3M	Rolado 4M
Sedente Solo 6M	Gateo 8M
Bípodo Sin Ayuda 12 M	Marcha 12M
Lenguaje Verbal 9M	Lenguaje Verbal Fluido 24M

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Ninguno	Otros Ninguno

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente cursa octavo grado en el Colegio Bilingüe Los Ángeles, en Aguachica. Muestra afinidad por las asignaturas de inglés y matemáticas, mientras que español y sociales no resultan de su agrado. Su círculo social es reducido, conformado por aproximadamente seis amigas con quienes mantiene una buena conexión y disfruta compartir los espacios de descanso.
Historia laboral No aplica
Historia familiar Actualmente reside con su madre, la Sra Alba Maritza Quiñones con 58 años, en el municipio de Aguachica. Su padre, el Sr Jairo Zubiria de 63 años, vive en la ciudad de Valledupar. Mantiene una relación cercana y positiva con la madre. En cuanto al vínculo con el padre, se encuentra en un proceso de acercamiento; el paciente señala que a veces percibe que su padre “lo utiliza como puente para acercarse a la mamá”.
Historia social Actualmente permanece la mayor parte del tiempo en casa. En etapas previas solía llorar cuando debía salir a la calle y continúa mostrando preferencia por permanecer en espacios cerrados. Disfruta planificar previamente cualquier salida y, cuando estas se presentan de manera espontánea, suele incomodarse. Se observa un estilo social retraído y con escasa expresividad emocional. La comunicación con la madre es funcional: responde adecuadamente a las preguntas que se le hacen, aunque presenta dificultades para sostener una conversación fluida o espontánea.
Historia socio-afectiva El paciente muestra enlentecimiento en los procesos de pensamiento (Bradipsiquia) y del habla (bradilalia), así como dificultades para iniciar interacciones sociales; mantiene escaso contacto visual y tiende a evitar el acercamiento con compañeros de su mismo sexo, prefiere tener lazos afectivos de amistad con el sexo femenino. Se observan adecuados niveles de sensibilidad y comprensión hacia las personas mas cercanas como la madre, aunque con expresión emocional disminuida, además de una marcada inestabilidad afectiva que varía de manera frecuente.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se llevó a cabo un proceso de valoración psicológica que incluyó la aplicación de una entrevista semiestructurada. El paciente fue remitido al área de neuropsicología para la administración de pruebas de coeficiente intelectual y la evaluación ADOS-2, con el propósito de confirmar o descartar un posible trastorno del espectro autista y obtener un perfil psicológico y cognitivo más preciso. Asimismo, se recomendó iniciar terapia familiar para abordar las dinámicas y tensiones que han contribuido al distanciamiento con la figura paterna.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

No refiere.

Otras intervenciones

No refiere.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

El paciente ingresa a la consulta acompañado de su madre. Se encuentra orientado en las esferas auto y alopsíquica. Presentación personal adecuada al entorno clínico, con higiene y vestimenta apropiadas. El saludo es de tono plano y se evidencia disminución marcada del contacto visual. Se observan estereotipias motoras finas a nivel de las manos. El lenguaje presenta pobre fluidez espontánea, limitándose a respuestas breves y directas ante las preguntas formuladas, sin iniciativa comunicativa. El afecto se aprecia restringido, con tono emocional predominantemente frío; sin embargo, se observan episodios aislados de sonrisa ante estímulos socialmente significativos (menciones a amistades). El curso del pensamiento es lógico y coherente, sin alteraciones formales. No se identifican ideas de contenido suicida ni elementos de corte delirante. No se evidencian alucinaciones ni alteraciones sensorio-perceptivas. El juicio se conserva, y la atención sostenida se mantiene adecuada durante la interacción clínica, aunque con limitada participación espontánea.

Ciclos del Sueño

Conservados, sin embargo la madre debe estar supervisando que se acueste en el horario apropiado.

Apetito

Conservado.

Actividades de Autocuidado

Independiente.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

La sintomatología observada es compatible con un posible Trastorno del Espectro Autista (TEA), clasificación F84.5 – Autismo en la niñez, por lo que se requiere continuar con el proceso diagnóstico diferencial para su confirmación o descarte.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Favorecer el desarrollo socioemocional, comunicativo y adaptativo del paciente mediante una intervención estructurada que fortalezca sus habilidades sociales, la regulación emocional y la integración sensorial, a la vez que se acompaña a la familia en el manejo adecuado de las dinámicas relacionales.

Objetivos Específicos

- **Fortalecer las habilidades sociales básicas y complejas**, incluyendo contacto ocular funcional, participación en conversaciones, iniciación y mantenimiento de interacciones, y reconocimiento emocional propio y ajeno.
- **Mejorar la regulación emocional y disminuir la variabilidad afectiva**, enseñando estrategias cognitivo-conductuales y técnicas de autocontrol aplicables en contextos sociales y familiares.
- **Intervenir en la comunicación verbal y paraverbal**, promoviendo mayor fluidez del lenguaje, tiempos de respuesta más ágiles y uso adecuado de expresiones emocionales.
- **Disminuir el malestar frente a estímulos sensoriales específicos**, mediante actividades graduadas de desensibilización y estrategias de afrontamiento sensorial.
- **Fortalecer la relación familiar**, especialmente la vinculación con la figura paterna, mediante sesiones de orientación familiar y acompañamiento terapéutico.
- **Acompañar el proceso de evaluación neuropsicológica y diagnóstico diferencial**, integrando los hallazgos para ajustar el plan terapéutico según las necesidades cognitivas y sociales del paciente.

Sugerencias e Interconsultas

- Interconsulta con Neuropsicología, para identificar el perfil cognitivo.

- Interconsulta con Terapia Ocupacional, con el propósito de explorar de manera integral el perfil de procesamiento sensorial del paciente, identificar posibles alteraciones en la modulación sensorial y abordar la rigidez o inflexibilidad cognitivo-conductual. Asimismo, se recomienda evaluar y trabajar los componentes motores finos y gruesos que puedan estar interfiriendo en su funcionamiento adaptativo.

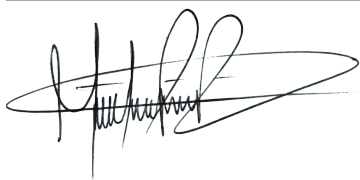
Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES:

- El paciente presenta indicadores compatibles con dificultades en la interacción social (poco contacto visual, retraimiento, estereotipias, hiponimia, lentitud en pensamiento y lenguaje), por lo que se requiere continuar el proceso de diagnóstico diferencial (TEA, trastornos del neurodesarrollo, trastorno de comunicación social, entre otros).
- Se evidencia sensibilidad sensorial marcada, que requiere intervención sistemática.
- La comunicación funcional se mantiene, pero con poca iniciativa y escasa espontaneidad.
- La fluctuación emocional requiere manejo clínico para favorecer la estabilidad afectiva.
- La dinámica familiar influye directamente en el malestar del paciente; la orientación familiar es esencial.

RECOMENDACIONES:

- **Continuar el proceso de evaluación neuropsicológica** y asistir a las citas programadas para completar el diagnóstico.
- **Asistir regularmente a terapia psicológica**, con frecuencia mínima semanal.
- **Implementar rutinas de anticipación y planificación** para reducir malestar ante cambios.
- **Favorecer espacios controlados de interacción con pares**, iniciando con actividades dirigidas.
- **Mantener comunicación clara y concreta**, evitando dobles sentidos o instrucciones ambiguas.
- **Reducir la exposición a estímulos sensoriales intensos**, e introducir desensibilización gradual guiada por el terapeuta.
- **Iniciar terapia familiar**, priorizando la mejora del vínculo con la figura paterna.
- **Registrar conductas relevantes** (interacciones sociales, irritabilidad, sensibilidad sensorial) para monitorear avances.
- **En la escuela, Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR)** [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5].
- **Tratelo con amor**, no se lo tome personal, sus conductas y falta de reciprocidad emocional hacen parte de un posible autismo.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542

Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER